Riflessione e discussione su *Il Cantone malato* - Talarico, R.

MC ANNO 2026/2027

1. La mentalità della popolazione

Mentalità rurale, conservatrice e chiusa, diffidente verso le novità: molti comuni chiedevano che le strade passassero lontano dai villaggi perché «portavano i ladri». Il mondo era popolato da spiriti, streghe e stregoni, a cui si attribuivano temporali e malattie. Davanti alla malattia e alla morte prevaleva il fatalismo; la morte di un figlio era accettata con rassegnazione.

2. Descrivi:

1. **Le condizioni socioeconomiche:** territorio poco produttivo (solo il 10% circa coltivato), agricoltura arretrata, proprietà frammentata, dipendenza dalle importazioni, forte emigrazione stagionale. Il lavoro pesante restava a donne, vecchi e bambini. Vita breve.
2. **La situazione alimentare:** diete povere e monotone (polenta, castagne, patate, legumi, pane di segale), sottoalimentazione diffusa. Carne solo nelle feste, mentre i ricchi mangiavano carne, uova e pesce. Molto vino, anche per i bambini. Cibi spesso avariati, causa di dissenterie. Nelle carestie del 1816-17 si mangiavano radici.
3. **La situazione igienico-sanitaria:** igiene personale scarsa, bagno quasi sconosciuto. Case sovraffollate, umide, buie, senza latrine, spesso condivise con gli animali. Letame e rifiuti nelle strade, fogne assenti o mal costruite, pozzi inquinati (analisi di Lugano del 1887), con frequenti casi di tifo.

3. Quale era la concezione eziologica (causa) di malattia nell'opinione corrente

La malattia non aveva una causa naturale: rientrava nel «male» ed era opera di forze malefiche (streghe, spiriti, folletti, demonio). Si credeva che il male potesse passare a un oggetto o a un animale («magia simpatica»). Anche i medici conoscevano poco le cause e parlavano di «miasmi», cioè di aria corrotta.

4. Diffusione e frequenza di malattie (morbilità), morbosità (quali malattie) e mortalità

- **Malattie ordinarie:** febbri, vaiolo, malattie respiratorie, dissenterie, reumatismi.
- **Malattie endemiche:** malaria (Piano di Magadino), tubercolosi, gozzo, cretinismo.
- **Epidemie:** tifo nel 1817-18 e colera nel 1836, 1849, 1854-55 e 1867.
- **Mortalità:** nel 1870 si contarono 15.695 casi e 1.179 morti. A Lugano, tra il 1876 e il 1885, circa 450 casi di tifo con 45 morti. Sul Piano di Magadino solo 8 persone su 960 superavano i 70 anni.

5. La condizione infantile

Mortalità infantile altissima. Madri al lavoro anche in gravidanza, neonati in ambienti malsani, spesso nelle stalle, nutriti con pappe indigeste o pane premasticato e affidati ad altri bambini. Presto mandati a lavorare nei campi, con danni fisici: nel 1860 circa il 23% delle reclute fu dichiarato inabile. I figli erano considerati «intercambiabili».

6. Operatori della salute presenti sul territorio e rimedi (medicamenti) profusi

- **Operatori:** guaritori, mammane, comari, empirici, conciaossa, barbieri e flebotomi (salassi), preti esorcisti. I medici erano pochi e poco consultati.
- **Rimedi:** formule, preghiere e reliquie; una pietra sul ventre per il mal di pancia, una gallina nera squartata sulla testa, un topo arrostito per la tosse, pidocchi nell'uovo per l'itterizia, lumache per lo stomaco, orina per i morsi di cane.

7. Quali gli interventi delle autorità, le misure ordinate e introdotte volte a migliorare la situazione

- Controlli su cibi, macelli e mercati, e sorveglianza delle frontiere.
- Circolari sul colera e ordinanze sulla pulizia delle strade.
- Divieto di tenere animali nelle stanze.
- Analisi delle acque, fontane e acquedotti.
- Proposta di bagni pubblici e statistiche mediche.
- Vaccinazione antivaiolosa obbligatoria.
- Bonifiche e chinino contro la malaria.
- Esclusione dei non qualificati dalle professioni sanitarie.

8. Medicina popolare e medicina colta: come si conciliano o dove vedi i punti di attrito

- **Si conciliano** perché molti rimedi popolari derivavano da vecchie teorie della medicina colta; anche i ricchi usavano rimedi popolari, e la medicina ufficiale non otteneva risultati molto migliori.
- **Si scontrano** perché i medici giudicavano le pratiche popolari «stupide superstizioni» e volevano «incivilire» il popolo, che rispondeva con diffidenza e ostilità. Le due concezioni della malattia erano opposte: razionale e magico-religiosa.

9. Come avviene il processo di professionalizzazione in ambito medico-sanitario

Dall'inizio dell'Ottocento lo Stato introduce leggi che riservano l'esercizio a chi ha i requisiti. Guaritori, comari ed empirici sono dichiarati illegali e accomunati ai ciarlatani. I medici ottengono l'esclusività, con l'appoggio dell'opinione pubblica colta.

10. L'introduzione di nuove idee si scontra con una certa opposizione. Prova a spiegarne le ragioni

- Isolamento e attaccamento alle tradizioni.

- Concezione magica della malattia, incompatibile con quella scientifica.
- Poca fiducia in una medicina che non dava risultati migliori.
- Norme imposte dall'alto, che turbavano l'ordine delle cose.
- Disprezzo delle classi colte verso il popolo.
- Povertà e scarsa istruzione.